



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شيماء محمد نجيب السيد
المحافظة : الجيزة
العنوان : شارع الفادي
رقم البطاقة : 28107108800202 رقم التليفون : 01019655112
العمر (تاريخ الميلاد) : 10-07-1981 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : قسم : -----
جهة العلاج : نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيماء محمد نجيب السيد National ID: 28107108800202	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





٢٠٢٥/٠٩ ٢٨١٠٧١٠٨٨٠٠٢٠٢

حاصلته على ليسانس أداب وتربية



أنثى مسلمة متزوجة
ولاء عبدالرافع علي الأشقر

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

١



Name: شيماء محمد نجيب السيد		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 6065			
Detailed Medical Report			
			السيد
تجربة طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها			
The patient is a 44-year-old individual with a history of right breast invasive ductal carcinoma (IDC), grade 2, estrogen receptor 8/8, progesterone receptor 5/8, HER2 positive, initially staged cT2N0. Neoadjuvant chemotherapy (NACT) was administered, followed by right wide local excision (WLE) with axillary lymph node dissection (ALND) in August 2022. Final pathology demonstrated a pathological complete response (pCR, ypT0N0). Post-operative radiation therapy (PORT) was completed, and the patient received one year of anti-HER2 therapy (Herceptin ± Perjeta). Since then, the patient has been maintained on tamoxifen 20 mg daily. In April 2026, the patient underwent a routine ultrasound of the abdomen and pelvis, which identified a uterine fibroid. A breast imaging review in June 2026 reported a BIRADS 2 lesion. Tamoxifen therapy was continued at 20 mg with supportive care for an additional three months, and the next clinic visit was scheduled for March 9, 2026. On August 9, 2026, the patient's record notes that the right WLE with ALND was performed in August 2022, confirming pCR (ypT0N0). A chest CT scan was requested, and tamoxifen 20 mg was continued with supportive care for three months, with the next visit planned for February 12, 2026. The patient remains on tamoxifen therapy and is under routine surveillance.			
تحريراً في ,			
		التاريخ : 20-09-2026	الوقت :
		نهي سعيد علي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,			

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جبهه الاصدار : فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ق) شيماء محمد نجيب السيد علي بطاقة رقم 28107108800202
وطبقا الى فصل او استقاله او انتهاء مدة خدمة
يعتبر من الفئات غير المنتفحه بالتأمين الصحي
وشكرا

تحريرا فى : 2022-8-9

الموظف المختص

امثال نعيم



افادة مركز نظم المعلومات
بمركز



الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

PATIENT NAME: Shalma Mohamed NAGEEB ELSAYYED GENDER: Female AGE: 40 y	PATIENT ID #: 2022182307 ORDER #: 1478387 DATE OF SERVICE: 19-Feb-2022 12:02 PM
--	---

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP in:

FINDINGS:-

Mild degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae, more at LV2.
Otherwise the rest of the surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
Both kidneys are seen.

Conclusion:-

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

19-Feb-2022 03:34 PM

ent Name : الأستاذة / شيماء محمد نجيب السيد	Request No. : 13007561
ent No. : 28107108800202	Request Date : 28/02/2022
No. : SR-150/2022	Verification Date : 07/03/2022
: Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
: 40 Y	Department : Out Patient
reing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

cal Data:
t breast cancer

re of the specimen:
revision.

ss Examination:
paraaffin block labeled as (996/22) and 3 slides were received.

roscopic examination:
istological type: Invasive duct carcinoma
rade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II(3+2+1)
Ductal carcinoma in situ: Minor
R: Strong nuclear staining of 100% of tumor cells
R: Strong nuclear staining of 50% of tumor cells
er2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells

agnosis:
ght breast cancer; Slide revision:
nvasive duct carcinoma, grade II, with minor DCIS component
R: Positive (Allred score 8/8)
R: Positive (Allred score 5/8)
er2: Positive (Score 3+)

Prof. Dr. Aml Hareedy
Dr. Walaa Ghonaim

Verified by :
walaa ghoniem

Printing Date : 09/03/2022 11:54:09

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

Patient Name : الأستاذ / شيماء محمد نجيب السيد
Patient No. : 28107108800202
Path No. : 2385/22
Sex : Female
Age : 41 Y.
Referring Doc :

Request No. :
Request Date : 17/08/2022
Verification Date : 08/09/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer, (post neoadjuvant therapy)

Nature of the specimen:

Right WLE & SLNs

Gross Examination:

Two specimens were received submitted as:

1-Right WLE measuring 7x5x1.5 cm, with skin covering, 4x2 cm. Cut section revealed an ill-defined firm grayish white clipped tumor bed site measuring 0.7x0.7x0.5 cm, located 1 cm, 3cm, 0.5cm, 2cm, 2.5cm, 3cm away from deep, superficial, inferior, superior, medial, lateral resection margin respectively.

axilla; 12x7x2 cm, entangling 8 nodules up to 1x1 cm.

2-Extramammary margin: Two Fibrofatty tissue pieces, 8x4 cm & 5x2 cm. Grossly unremarkable.

3- Extra-Inferolateral margin: Fibrofatty tissue pieces, 6x4 cm. Grossly unremarkable.

5- Sentinel lymph node: Two nodules ranging in size from 1.5x1 cm & 1x0.5 cm.

• Frozen section: Free margins & Extra margin

Microscopic examination:

- No remnants of tumor tissue
- Complete pathological response
- Angiolysis: No
- Ductal carcinoma in situ: yes (10%)
- Lymph node involvement: Free sentinel (0/2) & Free axillary nodes (0/3).
- Resection Margins: Free
- Additional pathologic findings: Hyalinosis & Fibrosis (Effect of therapy)

Verified by :

Dr. Marwa mahmoud

Printing Date : 06/09/2022 12:19:05

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

الطبيب: شيماء محمد نجيب السيد - الأستاذ / شيماء محمد نجيب السيد - 28107108800202 - 2385/22 - 41 Y. - Female - Out Patient - نفقة الدولة - اورام دار السلام - 17/08/2022 - 08/09/2022 - 2385/22 - 41 Y. - Female - Out Patient - نفقة الدولة - اورام دار السلام

Patient Name: Shaimaa Mohamed Naguib Al Sayed Ali	Date : 26/07/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 758/2022	Pat. ID: 15705

FOLLOW UP BILATERAL BREAST ULTRASOUND

INDICATION:

- Follow up post NACT for right breast malignant mass.

REPORT:

- ACR a: predominantly fatty parenchyma
- A metallic marking clip is noted in the right UOQ with no sizable mass or suspicious microcalcification. This area shows linear parenchymal distortion by ultrasound with no mass.
- No pathologically enlarged axillary, internal mammary or supraclavicular LNS
- No left breast suspicious mass lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Left nonspecific axillary lymph nodes.

OPINION:

- Follow up post NACT for a case of right breast malignant mass, showing good therapeutic response, with regressive course as regards the loco-regional with no sizable residual mass (BIRADS VI).
- Normal study of left breast (BIRADS I)

Signature Amira Hamed

26/07/2022 11:23 AM



Patient Name: Shaimaa Mohamed Naguib Al Sayed Ali	Date : 19/02/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 41 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 15705

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Status post right breast surgical intervention showing parenchymal distortion and skin thickening.
- Right upper lobe sub-pleural retico-nodular lesions likely post therapeutic sequel.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions on non contrast basis or contour irregularities.
- Multiple gall bladder stones are noted.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus with IUD seen within.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- No sclerotic or lytic lesions.

Opinion:



Patient Name: Shaimaa Mohamed Naguib Al Sayed Ali	Date : 19/02/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 41 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 15705

- ***Known case of breast cancer showing right breast surgical intervention with parenchymal distortion for sono-mammographic correlation.***
- ***No pulmonary or hepatic metastatic deposits on non-contrast basis.***
- ***Calcular gall bladder.***

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc

Signature: Prof. Menna Talla Hanafy

20/02/2023 05:32 م



Patient Name: Shaimaa Mohamed Naguib Al Sayed Ali	Date : 09/01/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 758/2022	Pat. ID: 15705

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had rt CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Asmaa Zenhom

09/01/2025 1:04 PM



Patient Name: Shaimaa Mohamed Naguib Al Sayed Ali	Date : 10/12/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 758/2022	Pat. ID: 15705

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had CBS in right side.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)

Yours truly

Dr.Wafaa Ali